

ELIANA RIBEIRO DE LIMA			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS			
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA			
HORA QUE DORME			
PRATICA EXERCICIO			
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
25/10 22	$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 10,5/\text{hr}$ m. de uso: 8hs <i>Ass</i>		
01/11 22	$P = 8,7 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 7,4/\text{hr}$ m. de uso: 8h16' Bem adaptado <i>Ass</i>		
17/11 22	$P = 9,8 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 7,2 \text{ elmin}$ m. de uso: 6h41', ajuste CPAP p/ fixo $\Rightarrow 8,0 \text{ cmH}_2\text{O}$		
30/11 22	$P = 9,8 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 5,7 \text{ elhr}$ m. de uso: 7h07' ajuste mass. <i>Ass</i>		
25/01 23	$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 4,7 \text{ elhr}$ m. de uso: 6h10' Relata que n' apref. o sono. <i>Ass</i>		
28/02 23	$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 4,2 \text{ elhr}$ m. de uso: 6h15' Bem adaptada, melhora da qualif. do sono <i>Ass</i>		
31/03 23	$P = 8,0 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 5,6$ m. de uso = 7hr. Bem adaptada <i>Ass</i>		
29/05/23	$P = 7,8 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 3,8 \text{ elhr}$ m de uso = 7 horas fuga = 8l/min Bem adaptado / tira a noite nas piores.		

31/07
23 P = 7.9 cmH₂O
IAH = 4.9 e/ev
m. de uso: 7h45'
Bem adaptado

Jua

25/09
23 P = 7.9 cmH₂O
IAH = 3.0 e/ev
m. de uso: 6h30'

Jua claudia

04/12
2023 P = 7.8 cmH₂O
IAH = 3.6 e/ev
m. de uso: 7h46'
fuga: 4 l/min.

Bem adaptada, unidif 4

Prinicial 5 cmH₂O
P: terapia 8 cmH₂O

CPAP.

15/01
24 P = 7.8
IAH = 4.
m. de uso: 7hs

Low air mini

03/07
24 P = 8 cmH₂O
IAH = 4.3 e/ev
m. de uso: 7h30'
Fuga = 1.3 lpm

Jua

Jua.

02/10
24 P = 8 cmH₂O
IAH = 2.2 e/ev
m. de uso: 7h
Aumentado 90% do tempo 4 de 4 hr.

Jua

10/02
25 P = 8 cmH₂O
IAH = 2.6 e/ev
m. de uso: 8hs
fuga = 7.1 lpm.

14/04
25 P = 8 cmH₂O
IAH = 4.6 e/ev
m. de uso: 7h45'

Jua claudia

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

Paciente: **ELIANA RIBEIRO DE LIMA** (65 anos)

Convênio: **Unimed**

Matrícula: **09700024003038235**

Relatorio medico.

Solicito avaliação para adaptação ao CPAP ocm pressão titulada de 90,0cm de H2O , manteve eventos na posição supina



Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

Sonografia

Ans drs ELTA 418

Tel 3921 4001

Ans Claudia

Nome: ELIANA RIBEIRO DE LIMA

Data de Nascimento: 1-9-1957

IMC: 30,02

Sexo: Feminino

Data do exame: 12-08-2022

Peso: 74 kg

Altura: 1,57 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 549,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 19,0 e 192,0 minutos. O tempo total de sono foi de 408,0, eficiência de 74,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 58,8%; estágio N3: 20,1%; sono REM: 18,5%. O índice de despertares foi de 20,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 39,6/hora, sendo elas 65 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 67 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 80%, permanecendo 6,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 46 - 71 bpm e NREM de 46 - 78 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 39,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=80%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (1,5/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa

Medicina do Sono

CRM 57/57

Nome: ELIANA RIBEIRO DE LIMA
Data de Nascimento: 1-9-1957
IMC: 30,02
Sexo: Feminino
Data do exame: 21-09-2022

Peso: 74 kg
Altura: 1,57 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 21-09-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 453,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 48,0 e 78,5 minutos. O tempo total de sono foi de 318,5, eficiência de 70,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 57,9%; estágio N3: 19,9%; sono REM: 19,3%. O índice de despertares foi de 19,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 31,3/hora, sendo elas 99 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 67 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 80%, permanecendo 6,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 44 - 70 bpm e NREM de 45 - 74 bpm.

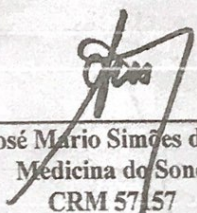
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco moderado durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157